

Cuidados Paliativos

Tips n’ Tricks

ANALGÉSICOS

não opioides

FÁRMACO	DOSE ADULTA USUAL (OTIMIZADA)	ONDE AJUDA MAIS	CONTRAINDICAÇÕES / QUANDO EVITAR
Dipirona	1 g VO/EV 6–8 h. Máx. 4 g/dia (regra prática)	Dor nociceptiva leve a moderada, dor visceral, febre. Ótima coanalgésica com opioide	Alergia a pirazolonas, agranulocitose/discrasia prévia, supressão medular. Cautela em IR/IH e hipotensão, sobretudo EV
Paracetamol	750–1.000 mg VO 6–8 h. Máx. 4 g/dia (adulto saudável). MS: 500–1.000 mg 6/6 h	Dor nociceptiva leve, musculoesquelética, febre. Associável a opioide	Hepatopatia grave, hepatotoxicidade prévia. Reduzir teto: baixo peso, fragilidade, etilismo, desnutrição, doença hepática
Ibuprofeno	400–600 mg VO 8/8 h (6/6 h por curto período). Teto ≈ 2.400 mg/dia	Dor inflamatória, óssea, musculoesquelética, metástase óssea, artralgia	IRA/DRC, úlcera/sangramento GI, anticoagulação de alto risco, IC descompensada, hipersensibilidade/broncoespasmo por AINE. ESMO: toxicidade GI e renal
Naproxeno	500 mg VO 12/12 h	Dor inflamatória e óssea; duração mais longa	Mesmas CI dos AINEs: DRC/IRA, úlcera/sangramento GI, alto risco hemorrágico, IC descompensada, alergia
Diclofenaco	50 mg VO 8/8 h, máx. 150 mg/dia	Dor inflamatória, musculoesquelética e óssea	CI dos AINEs; cautela CV, renal e GI. Evitar uso prolongado sem indicação clara
Cetoprofeno	50–75 mg VO 8/8 h ou formulação prolongada	Dor inflamatória e osteomuscular	CI dos AINEs, especialmente DRC e sangramento GI
Celecoxibe	100 mg VO 12/12 h ou 200 mg/dia	Dor inflamatória com menor agressão GI que AINE não seletivo	DCV relevante, DRC/IRA, alergia a sulfonamidas (conforme contexto), perioperatório de CRM. Menor risco GI ≠ sem risco renal/CV

ADJUVANTES

coanalgésicos

MEDICAMENTO	DOSE ADULTA PRÁTICA (OTIMIZADA)	MELHOR INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÕES / CAUTELAS
Dexametasona	4–8 mg/dia : dor neuropática por infiltração/compressão ou distensão capsular. 8–16 mg/dia : HIC ou compressão medular	Edema tumoral, compressão nervosa, metástase cerebral, HIC, distensão capsular hepática, compressão medular	Infecção não controlada, hiperglicemia, psicose/delírium por corticoide, miopatia, sangramento GI. Menor dose e menor tempo possíveis
Gabapentina	300 mg à noite → 300 mg 12/12 h → 300 mg 8/8 h. Faixa eficaz 900–3.600 mg/dia + 3	Dor neuropática: queimação, choque, alodinia, radiculopatia, plexopatia tumoral	Ajuste obrigatório na DRC. Sedação, tontura, confusão, edema. Idoso/frágil: iniciar 100 mg à noite
Pregabalina	25–75 mg 12/12 h. Usual 150–300 mg/dia. Máx. 600 mg/dia	Dor neuropática com titulação mais simples que gabapentina	Ajustar na DRC. Sedação, tontura, edema, confusão. Somação de sedação com opioides
Amitriptilina	10–25 mg à noite; em paliativos, 25–75 mg/noite costuma bastar	Dor neuropática, especialmente com insônia	Idoso frágil, delírium, retenção urinária, glaucoma de ângulo fechado, constipação, hipotensão postural, cardiopatia/condução. Anticolinérgico
Duloxetina	30 mg/dia → 60 mg/dia (alvo usual)	Neuropatia periférica, sobretudo induzida por QT; dor neuropática + depressão/ansiedade	IH importante, IMAO, cautela em DRC avançada, HAS não controlada, síndrome serotoninérgica. Náusea inicial
Carbamazepina	100–200 mg 1–2x/dia, titular. Faixa 400–1.200 mg/dia	Neuralgia do trigêmeo e neuralgias paroxísticas	Muitas interações, hiponatremia, mielotoxicidade, hepatotoxicidade, rash grave. Não é rotina para toda dor neuropática
Lidocaina 5% tópica	Adesivo na área dolorosa, até 12 h ligado / 12 h desligado	Dor neuropática focal com alodinia/hiperalgesia superficial	Pele lesionada, mucosa, área extensa. Pouco útil em dor profunda/difusa
Capsaicina tópica	Creme, várias vezes ao dia conforme produto	Dor neuropática localizada	Ardor importante, pele lesionada, mucosas. Pode ser mal tolerada
Bisfosfonatos	Conforme agente (ex.: zoledronato em esquemas específicos)	Dor por metástase óssea difusa ou recorrente	DRC, hipocalcemia, osteonecrose de mandíbula. Avaliação odontológica se uso prolongado
Denosumabe	Esquema conforme indicação oncológica	Metástases ósseas; prevenção de eventos esqueléticos e recorrência de dor	Hipocalcemia, osteonecrose de mandíbula. Corrigir Ca/vit. D; avaliação odontológica
Cetamina	Uso especializado; doses subanestésicas individualizadas	Dor refratária complexa, componente neuropático/sensibilização central após falha	Psicose, delírium, HAS grave, DCV relevante. Evidência limitada para uso rotineiro

ANTIDIARREICOS

constipantes · escalonamento

#	FÁRMACO	DOSE ADULTA PRÁTICA	ONDE ENTRA	EVITAR / CAUTELA
1	Racecadotril	100 mg VO 8/8 h	Diarreia aquosa/secretória sem sinais invasivos	Não usar isolada em diarreia grave, sanguinolenta ou infecciosa suspeita
2	Loperamida	4 mg, depois 2 mg após cada evacuação não formada ou 2–4 h. Máx. 16 mg/dia	1ª escolha sintomática na maioria das diarreias não complicadas	Íleo, distensão, obstrução, colite grave, enterocolite neutropênica, diarreia sanguinolenta/febril sem investigação
3	Codeína	15–30 mg VO 4–6 h, titular	Refratária à loperamida, sobretudo em paliativos	Sedação, depressão respiratória, delírium, IR, interação com opioides
4	Tintura de ópio	Equiv. morfina 10 mg/mL; 10–15 gotas 3–4 h	Muito refratária, após falha das demais	Riscos dos opioides. Alto risco de erro de concentração / confusão com paregórico
5	Octreotida	100–150 mcg SC 8/8 h, até 500 mcg 8/8 h. Grave: 25–50 mcg/h EV contínuo	Grave, volumosa/secretória refratária; fistulas; tumores neuroendócrinos; induzida por tratamento oncológico	Bradycardia, disglicemia, cólica, coelítiaze (uso prolongado). Não substitui investigar a causa

Regra geral para palição: poucas doses necessárias → **PRN** ou **horário fixo**. Muitas doses de resgate em 24 h → transforme parte dessa necessidade em **dose basal contínua**. Sintoma contínuo + perda de VO + últimos dias de vida → **BIC** frequentemente é a melhor estratégia.

LAXATIVOS

constipação

Osmótico · Lactulose 10–20 mL VO 1–2x/dia; titular pela resposta - Gases, distensão, cólicas; desagradável se já muito distendido - Não é necessariamente 1ª escolha na constipação importante por opioide	Osmótico · PEG / macrogol - Excelente; mais previsível que lactulose - Dose inicial 17 g VO/dia - Ideal se fezes endurecidas; boa tolerabilidade - ESMO: PEG, lactulose e estimulantes são preferenciais em paliativos
Estimulante · Sene - Trata a hipomotilidade: ↑ motilidade colônica e ↑ secreção intestinal - Em geral à noite; frequentemente com osmótico	Estimulante · Bisacodil - Efeito mais intenso; 5–10 mg/dia - VO (persistente) ou supositório (fezes no reto) - Pode causar cólicas. ESMO inclui bisacodil e picossulfato
PAMORAs — antagonistas μ periféricos Bloqueiam receptores μ intestinais, pouca penetração no SNC. Metilnaltrexona SC: resposta rápida — muitos evacuam em ≈ 90 min. Naloxegol e naldemedina : VO.	

Escada geral

- 1 Lactulose
- 2 PEG
- 3 Sene
- 4 PEG + sene
- 5 Bisacodil
- 6 Supositório / enema se reto cheio
- 7 Desimpactação se fecaloma

Constipação por opioide (OIC)

- 1 Iniciar laxante junto do opioide
- 2 Estimulante (sene ou bisacodil)
- 3 Associar PEG
- 4 Otimizar doses e avaliar fecaloma
- 5 Medida retal se reto cheio
- 6 PAMORA se OIC refratária
- 7 Metilnaltrexona SC (selecionados)

ANTISSIONALAGOGOS

sialorreia · “death rattle”

Dois cenários: **sialorreia verdadeira** (produção/acúmulo excessivo de saliva) e **secreção respiratória ruidosa no fim de vida** (“death rattle”). NICE: atropina, glicopirrônio, butil- ou hidrobrometo de escopolamina.

FÁRMACO	FORÇA	DOSE	VANTAGEM / INDICAÇÃO	LIMITAÇÃO / EVITAR
Amitriptilina	+	10–25 mg à noite	Sialorreia crônica leve, consciente, com VO; dor neuropática; insônia	Ruim para secreção terminal aguda. Delírium, retenção, íleo, constipação, glaucoma, QT longo, hipotensão postural, idoso frágil
Atropina SL (colírio 1%)	++	NICE: 1–2 gotas SL 4–6 h; outras diretrizes: até 4 gotas SL 4/4 h SN	Simples, rápida, sem acesso; resgate	Atravessa BHE: delírium, retenção, taquicardia. Íleo, glaucoma, secreção já espessa
Glicopirrônio	+++	400 mcg SC 6–8 h SN ou 600–1.200 mcg SC/24 h	Forte efeito periférico, quase não penetra SNC — ótimo se delírium	Disponibilidade limitada. Retenção, íleo, constipação, glaucoma, taquicardia; cautela na IR
Butilbrometo de escopolamina (Buscopan)	+++	20 mg SC/IV intermitente; NICE: 60 mg SC/24 h	Excelente SC/bomba; também cólica, espasmo GI, obstrução intestinal maligna	Xerostomia, retenção, constipação, glaucoma, taquiarritmia, miastenia gravis
Hidrobrometo de escopolamina	++++	NICE: 400 mcg SC 6–8 h ou 1.200 mcg SC/24 h	Antissecrotor potente + sedativo (atravessa BHE)	Delírium, agitação/confusão, sedação, retenção, glaucoma, íleo, taquiarritmia

Qual escolher?

Consciente, sialorreia crônica, ainda VO	→ Amitriptilina , se houver espaço p/ efeito anticolinérgico
Resgate simples e rápido	→ Atropina SL
Paciente já delirante	→ Glicopirrônio (mínima passagem pela BHE)
Terminal com secreção + cólica/obstrução	→ Butilbrometo de escopolamina
Terminal, secreção importante, sedação aceitável	→ Hidrobrometo de escopolamina

Atenção: secreção já muito espessa e difícil de mobilizar → aumentar anticolinérgico pode piorar (reduz água e torna a secreção mais tenaz).

Pouco resgate, dose à parte.

SN

Muito resgate, basal no combate.

De horário

Sem VO no fim da vida, BIC é a saída.

BIC

BOMBA DE MORFINA

BIC

1. **Somar** toda a morfina usada nas últimas 24 h
2. Correr essa dose em **24 h**, diluída para **100 mL de SF**
3. Resgate = **1/6** da dose total diária
4. Resgates usados → **somar** à dose total do dia seguinte
5. Manter **sempre** resgates para ajustes

Opioide-naïve: iniciar protocolo de **5 mg/24 h**. · **BIC** é sempre melhor que morfina de horário.

Morfina é analgésico — não deve ser usada como agente de sedação paliativa (INCA).

BOMBA DE FENTANIL

dose inicial 25 mcg

Quando trocar a morfina	INFUSÃO SC	RESGATE SC
1. DRC avançada	50 mcg/24 h	25 mcg
2. Neurotoxicidade: mioclonias, delírium, hiperalgesia, sedação desproporcional	100 mcg/24 h	25 mcg
3. Intolerância à morfina	150 mcg/24 h	25 mcg
4. Sem VO, precisando de opioide parenteral contínuo	300 mcg/24 h	50 mcg
5. Grande potência em volume pequeno	450 mcg/24 h	75 mcg
	600 mcg/24 h	100 mcg

Opioide-naïve · titular com bolus pequenos

Iniciar **50 mcg/24 h** de fentanil ≈ morfina 5 mg

1. Fazer solução de **10 mcg/mL**
2. 50 mcg = **5 mL** dessa solução
3. Diluir em **SF** ou **SG**

DRC 4–5 em infusão SC: alguns serviços preferem **alfentanil** — opioide de escolha para syringe pump nas Scottish Palliative Care Guidelines (farmacocinética favorável, sem ajuste renal).

SEDAÇÃO PALIATIVA

midazolam

1. Indução: **5 mg EV**
2. Solução **1 mg/mL** → iniciar **1 mL/h**
3. Resgates de **5 mg 1/1 h** SN
4. Titular pelo **conforto** — não existe dose-alvo
5. MS permite titular até **20 mg/h**

Ex.: 1 mg/h e, após 1 h, ainda angustiado/agitado
Repetir bolus **2–5 mg** → ↑ infusão em **≈ 1 mg/h** → reavaliar → repetir até conforto (*manual brasileiro*).

AGITAÇÃO SEM DOR

Ansiedade ou inquietação → Midazolam
2,5 mg SC ou IV; se precisar de várias doses → considerar bomba.
Fim de vida: associar **levomepromazina 12,5 mg SC/IV 2/2 h** — preferir bomba, iniciando **12,5–50 mg/24 h**.

Delírium hiperativo → Haloperidol

- **1 mg IV ou SC** “sem medo”; NICE: **1–2 mg SC até 3x/dia**
- Bomba: **2,5–5 mg SC/24 h**
- Resgates com **midazolam** SN

Cuidado com haloperidol: Parkinson, demência com corpos de Lewy, QTc longo, hipoK/hipoMg importantes, vários fármacos que prolongam QT, história de extrapiramidalismo. Pode causar ↑QT, parkinsonismo, distonia e acatisia.